

37. LE CERVEAU PRATIQUE

DURÉE : 13:08

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo 'Le Cerveau Pratique' présente une approche biodynamique détaillée centrée sur le cerveau et son expansion. L'instructeur enseigne comment identifier les niveaux d'expansion chez le patient, en explorant des stratégies de redynamisation efficaces, telles que le travail sur le cœur et les axes digestifs. S'ensuit une exploration des mouvements de flexion céphalique et pontine, avec des précautions spécifiques à prendre lors du toucher. En se concentrant sur la sensation d'expansion, les praticiens apprendront à accompagner le mouvement d'encéphalisation, en comprenant le rythme et la synchronicité liés à l'embryologie biodynamique. Cette session est à la fois théorique et pratique, promettant aux étudiants une compréhension enrichie et des compétences développées pour améliorer leur pratique.

37. LE CERVEAU PRATIQUE : APPROCHE BIODYNAMIQUE

I. POSITIONNEMENT INITIAL ET RECHERCHE DE L'EXPANSION

Je me positionne au-dessus du patient, spécifiquement au niveau de l'**insula**. Mes mains sont placées ici, mes pouces se croisant légèrement, et je m'assure d'avoir un bon point d'appui pour mes coudes et mes poignets sur la table.

Le **toucher** est extrêmement doux. Je cherche à ressentir l'**expansion** du champ.

A. IDENTIFIER LE MANQUE D'EXPANSION

La toute première chose à évaluer est le niveau d'**expansion**. Si l'expansion est insuffisante et que je ne suis pas suffisamment "repoussé", c'est un signe que quelque chose ne va pas.

Souvent, on s'attend à une expansion immédiate et forte, mais ce n'est pas toujours le cas.

B. STRATÉGIES DE REDYNAMISATION EN CAS DE MANQUE D'EXPANSION

Si l'expansion est insuffisante, plusieurs pistes sont à explorer pour **redynamiser** le système :

- **Le cœur** : Alléger le cœur est souvent une approche très efficace.

- **Les axes digestifs** : Travailler sur les axes digestifs (mésentériques, mésarriques) ou l'axe coeliaque peut apporter l'expansion nécessaire.
- **Le sacrum et les pédicules** : Remonter jusqu'au sacrum et aux niveaux pédiculaires peut aussi aider.

En général, travailler avec le cœur ou les axes digestifs permet d'obtenir des résultats plus rapides et plus efficaces.

II. LE MOUVEMENT DE FLEXION ET L'ENCÉPHALISATION

Une fois l'expansion présente, je ressens une expansion suivie d'un mouvement de **flexion** vers l'avant. C'est la flexion céphalique, qui amène le cerveau vers le cœur.

Derrière, je dois percevoir un mouvement de **flexion cervicale**. Si je ressens un léger déficit à ce niveau, cela indique la nécessité d'une correction cervicale ou structurale.

A. LA FLEXION PONTINE ET LA TÉLÉ-ENCÉPHALISATION

Je me concentre ensuite sur mes petits doigts et cherche la **flexion pontine**. Le mouvement descend.

Puis, une nouvelle expansion apparaît. À ce stade, je peux ouvrir ma main. C'est le début du processus de **télé-encéphalisation**, qui est récupéré du niveau occipital vers le niveau temporal.

B. ERREURS COURANTES ET PRÉCAUTIONS

La plupart des erreurs surviennent lorsque l'on touche directement le cerveau. Il est impératif de ne pas toucher au cerveau si l'on n'est pas "sous cette fréquence".

- Je me positionne au-dessus, sans toucher avec mes pouces, maintenant une belle distance.
- Je crée un **fulcrum** très doux avec mes pouces et un point d'appui important.

C. LA SENSATION D'EXPANSION

Une bonne expansion est ressentie comme un plan de chaleur et une sensation de poussée douce.

III. LE MOUVEMENT SÉQUENTIEL ET L'ACCOMPAGNEMENT

J'effectue un mouvement très doux. Ce n'est pas encore mon "H-pont insulaire". Je fais le mouvement de flexion vers l'avant. Le mouvement descend bien, mais peut partir légèrement en torsion (par exemple, vers la gauche). J'accompagne très légèrement cette torsion.

À ce stade, une petite correction peut être nécessaire, potentiellement au niveau cardiaque. Il peut y avoir un moment où le mouvement n'est pas parfait, mais ce n'est pas grave.

A. DESCENTE DE LA FLEXION ET PLAN PONTIQUE

Je me dirige ensuite vers la descente de la flexion, que le patient doit sentir distinctement. Cela descend sans problème.

Une fois cela établi, je passe au **plan pontique**. Ici aussi, une petite intervention peut être requise.

B. LE PLAN TÉLENCÉPHALIQUE ET L'EXPANSION MONTANTE

Après le plan pontique, je reporte mon attention sur le **plan télencéphalique**, l'ébauche télencéphalique. Le mouvement doit venir vers moi. J'observe une expansion.

Je me positionne sur le "**Hitchman**" : le mouvement tourne vers moi, s'expand et monte.

C. LE GRAND MOUVEMENT D'ENCÉPHALISATION

Le mouvement repart, redescend et s'exprime. Je redescends tout doucement dans la grande flexion, le grand mouvement de l'**encéphalisation**. Je récupère ce mouvement au niveau occipital.

Il est crucial d'accompagner ce mouvement, de ne pas l'imposer. On attend qu'il s'affiche, puis on le suit. Le mouvement est déjà présent, comme un "rail dessiné", avec un rythme particulier. On ne fait que reproduire le **pattern** existant.

IV. LA COMPRÉHENSION DU RYTHME ET LA SYNCHRONICITÉ

Ce pattern n'est pas reproductible dans le sens d'un cycle qui se répète périodiquement. C'est un système qui est constamment là, une **écriture dans le corps**. C'est l'essence même de l'**embryologie biodynamique** : l'ébauche des structures (oreilles, système oculaire, placode optique, etc.) se met en place selon ce pattern.

Nous allons rajouter des éléments à cette compréhension, mais après avoir saisi cette ligne directrice.

A. LIER LES STRUCTURES ÉMÉRGENTES AU MOUVEMENT

Comprendre ce mouvement permet de voir comment les **ventricules** se mettent en place, comment la **dure-mère** suit, comment le **crâne** se forme. Si quelque chose bloque (un niveau que je ne connais pas encore), je peux m'appuyer sur ma connaissance du timing et des phénomènes synchrones.

Par exemple, je peux rechercher une **artère** ou un niveau électrique spécifié. Le patient pourra ressentir ce qui se passe.

B. L'IMPORTANCE DE LA DYNAMIQUE CARDIAQUE

Il est essentiel de bien connaître la **dynamique** du cœur. Parfois, l'expansion est plus importante d'un côté (par exemple, à gauche).

C. ÉVITER L'INTELLECTUALISATION EXCESSIVE

Il est important de ne pas intellectualiser excessivement le ressenti. Une trop grande activité mentale peut "mettre trop d'électricité dans le système limbique" et nuire à la perception subtile.

V. CAS PRATIQUE : ANALYSE D'UN RESENTI

Lors d'une évaluation :

- L'expansion est douce, pas complète. La flexion est bonne mais manque de dynamisation.
- Le rythme est variable. Le mouvement bascule davantage sur un rail à gauche, avec un ralentissement.
- Il est parfois difficile de rejoindre le **lobe frontal** en profondeur.

A. PROGRESSION DU MOUVEMENT

Ensuite, on passe au système pontique, avec une ascension du tube du patient. Je deviens point d'appui, et cela pousse. L'expulsion latérale, notamment à droite, démarre plus fort.

Le patient "récupère le paquet en bas". Après un démarrage initial un peu lent, le mouvement se rattrape bien.

B. LE TÉMOIGNAGE DU PATIENT

Le patient décrit un début difficile, comme s'il fallait se "mettre en route", lâcher une fixation à gauche qui empêchait l'expansion. La flexion initiale était difficile.

Lorsqu'une connexion a été établie, le système s'est "débloqué". Cela est comparable à apprendre à conduire une **Formule 1** : au début on est maladroit, puis avec l'apprentissage, cela fonctionne.

C. LES CLÉS DE L'ACCOMPAGNEMENT

- **Environnement et espace** : Laisser respirer, basculer le mouvement.
- **Progressivité** : Rentrer progressivement et se connecter à cette "écriture" du corps.
- **Centrage de l'écoute** : Centrer son écoute au niveau du cerveau, et si cela ne "va pas", observer ailleurs.

C'est une question de **synchronicité**. Il faut "se faire un synchronisme" pour trouver le mot juste et travailler avec cette synchronicité.